

WELSON ALMEIDA VASCONCELLOS

22231695997 || 470

IDADE: 52 PESO: 80 ALTURA: 186 PROFISSÃO: Imobiliário

SINTOMAS: acordar cansado

QUEIXAS: Qualidade do sono / Prejuízo

MEDICAMENTOS: geifage / liples / Sinthroid / Cardolafil / Nebloc

MÉDICO: Dr. Flávio

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x Pilates

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 00:30 HORA QUE ACORDA:

COCHILO ☒ SIM () NÃO *às vezes* DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUALBEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () NÃO *às vezes* X NA SEMANA () NÃOFUMO () SIM ☒ NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: —

OVERLAP: MALLAMPATI: II IAH: 41.3 SPO2: 74%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Sacro ilíaca / Cervical / Lesão trapezoid

CIRURGIAS: (S) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA Transpl. Mdr.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS

CPAP = 6.8 cmH₂O - 4.1 e/ev SpO₂ = 78%O₂/OS P = 6.8 cmH₂O

24 IAH = 7.0 e/ev

modo uso: 8h42'

Flow = 2.0 lpm.

fua.

Flavio Augusto Passarelli Prado

ORRINOLARINGOLOGIA

M 100701

duação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP
autorado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Welson Almeida Vasconcellos

Solicito:

- adaptação CPAP a pressão sugerida a 6,8cmH2O

G47.3

Dr. Flavio A. P. Prado
Otorrinolaringologista
CRM: 100.701



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Welson Almeida Vasconcellos

EXAME nº: 5488-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado

DATA: 11/03/2024

IDADE: 52 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 22h43min e concluído às 06h19min. A latência para o sono foi de 14 minutos e a latência para o estágio REM, de 266 minutos. O tempo total de sono foi de 424,5 minutos (07h04min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 92%. A distribuição do sono mostrou 6,4% de estágio 1, 27,3% de estágio 2, 54,7% de estágio 3 e 11,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 19 minutos em vigília, ocorreram 65 microdespertares (índice: 9,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 56,3/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 4,1/hora, sendo 1 apneia/hora e 3,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 4,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 91%, sendo a média de 94% e a mínima de 78%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,8 cm de H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (4,1/hora; índice normal: 4/hora) e de distúrbio respiratório (4,1/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e o ritmo cardíaco foi sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 57; máxima: 76 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 14 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 22h00min. A latência para o sono REM estava alongada (266 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (92%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (9,2/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento da porcentagem do estágio 3 (54,7%; normal: 10-12%) e a redução dos estágios 1 (6,4%; normal: 8-10%), 2 (27,3%; normal: 45-55%) e REM (11,7%; normal: 20%).

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (56,3/hora; índice normal até 15/hora).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730



DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Welson Almeida Vasconcellos

EXAME nº: 5488

SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado

DATA: 20/09/2023

IDADE: 51 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

CRM-SP 69730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 62858

Comentários:

Exame iniciado às 22h33min e concluído às 06h55min. A latência para o sono foi de 16 minutos e a latência para o estágio REM, de 278 minutos. O tempo total de sono foi de 468,5 minutos (07h48min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 93,1%. A distribuição do sono mostrou 4,1% de estágio 1, 57,3% de estágio 2, 29,9% de estágio 3 e 8,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 18,5 minutos em vigília, ocorreram 123 microdespertares (índice: 15,8/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 22,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 41,3/hora, sendo 15,1 apneia/hora e 26,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 45,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a média de 92% e a mínima de 74%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono

TTR ⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (41,3/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (45,4/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 64; máxima: 90 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 16 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (278 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono manter-se no limite da normalidade (93,1%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 15,8/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 2 (57,3%; normal: 45-55%) e 3 (29,9%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 1 (4,1%; normal: 8-10%) e REM (8,8%; normal: 20%).

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (22,8/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 10 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730